Parte quarta

Le funzioni strategiche

16_Oasi.indd 2 01/12/25 17:52

16 Revenue model nelle aziende sanitarie italiane: pubblico e privato accreditato a confronto

di Francesca Lecci, Mario Del Vecchio e Valeria Rappini[1]

16.1 Introduzione

Negli ultimi due decenni, la sostenibilità economico-finanziaria delle aziende sanitarie italiane – pubbliche e private accreditate – è divenuta un tema strutturale di governance, in un contesto segnato da vincoli di spesa pubblica, rigidità tariffarie e crescente domanda di salute. In tale scenario, la capacità delle organizzazioni di generare ricavi non istituzionali – ossia entrate derivanti da fonti diverse dal finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o dai contratti di accreditamento – rappresenta oggi una dimensione cruciale di autonomia gestionale e di resilienza organizzativa. L'autonomia economica delle aziende sanitarie, infatti, è una condizione necessaria per esercitare una reale responsabilità manageriale, ma rimane fortemente vincolata da regole di finanziamento e controllo pubblico. Questi ricavi derivano da, a titolo esemplificativo, dalle attività libero-professionali intramurarie, dalle prestazioni a pagamento diretto da parte degli utenti (*out-of-pocket*), da quelle remunerate tramite convenzioni con fondi sanitari integrativi o imprese, dai progetti in partnership pubblico–privato, dalle attività di formazione, ricerca e sperimentazione clinica conto terzi, nonché dalle nuove forme di servizi digitali e di telemedicina a pagamento. Si tratta di fonti di reddito che, pur quantitativamente minoritarie rispetto ai trasferimenti istituzionali, assumono un ruolo strategico sotto tre profili fondamentali.

I ricavi non istituzionali costituiscono spesso la principale risorsa "libera" di cui le aziende dispongono per finanziare innovazioni organizzative, tecno-

[1] Il capitolo ha beneficiato delle attività di ricerca svolte nell'ambito dell'*Osservatorio Consumi Privati in Sanità* (OCPS) di SDA Bocconi. Si ringraziano tutti i componenti del team OCPS per il supporto. Si ringraziano, per la preziosa collaborazione: l'ASL di Piacenza, l'ASST Spedali Civili di Brescia, l'ASP di Bolzano, il Centro Diagnostico Italiano, la Fondazione Don Carlo Gnocchi e il Policlinico San Donato. Sebbene il capitolo sia frutto di un comune lavoro di ricerca, il §16.6 è attribuito ai tre autori congiuntamente, i rimanenti §§ a Francesca Lecci.

logiche e infrastrutturali non coperte dai budget vincolati o dai tetti di spesa regionali. In un contesto in cui l'85–90% dei bilanci è assorbito da costi incomprimibili, anche variazioni limitate di entrate discrezionali possono generare margini di manovra significativi per progetti di sviluppo o digitalizzazione.

Per le aziende pubbliche, e in certa misura per gli erogatori accreditati, la capacità di sviluppare canali di ricavo propri non coincide con un processo di privatizzazione, bensì con l'affermazione di un modello di managerialità pubblica evoluta. In tale prospettiva, la sostenibilità economica non dipende unicamente dal trasferimento istituzionale, ma anche dalla capacità di attrarre risorse non istituzionali, valorizzando competenze cliniche, reputazione e innovazione di servizio. Come osservano Pollitt e Talbot (2004), l'autonomia nel settore pubblico si configura come un equilibrio dinamico tra discrezionalità e accountability: essa non implica l'assenza di vincoli, ma la capacità di gestirli in modo proattivo e responsabile.

La logica non è dunque di sostituzione del pubblico con il privato, ma di co-produzione del valore all'interno di un sistema regolato. La generazione di ricavi non istituzionali apre una riflessione etica e politica, oltre che economica: come conciliare la logica dell'autofinanziamento con i principi di equità e universalismo del SSN? L'evoluzione normativa e la spinta verso modelli di *value-based healthcare* (Porter & Lee, 2013) suggeriscono che la vera sfida non è evitare il mercato, ma governarlo, costruendo meccanismi di pricing, partnership e reinvestimento capaci di preservare l'accessibilità alle cure e, al contempo, garantire la sostenibilità delle organizzazioni.

Da un punto di vista analitico, l'interesse per i revenue model non istituzionali nasce dall'esigenza di comprendere come le aziende pubbliche e private accreditate stiano reinterpretando il proprio spazio economico entro i confini di un sistema fortemente regolato. Nel pubblico, ciò si traduce nella ricerca di fonti autonome di entrata che affianchino il finanziamento per quota capitaria, DRG o budget storico – ad esempio le attività libero-professionali, i servizi accessori o la ricerca conto terzi. Nel privato accreditato, significa invece sviluppare canali off-budget – dal *fee-for-service* privato ai contratti con imprese e assicurazioni – per compensare la rigidità dei tetti di spesa e l'erosione dei margini tariffari.

La rilevanza del tema, dunque, va ben oltre l'aspetto contabile: la capacità di generare ricavi autonomi costituisce oggi un indicatore chiave della maturità manageriale delle aziende sanitarie, della loro propensione all'innovazione e della capacità di orientarsi verso modelli di servizio sostenibili, competitivi e coerenti con il mandato pubblico.

In sintesi, i *revenue model* non istituzionali rappresentano un terreno promettente – ma anche controverso – per analizzare l'evoluzione del rapporto tra autonomia economica, accountability pubblica e creazione di valore in sanità. Essi offrono una prospettiva utile per osservare come il sistema sanitario ita-

liano stia evolvendo, da un modello prevalentemente pubblico-amministrato verso forme più articolate di collaborazione tra attori diversi, in cui la logica economica si affianca – senza sostituirla – alla missione pubblica di tutela della salute.

Il lavoro di ricerca, dopo una ricognizione delle teorie di riferimento prevalentemente utilizzate in tema di revenue model in contesti sanitari e di quasi mercato (§16.2), dettaglia il framework e il metodo di ricerca (§16.3), per poi presentare le evidenze raccolte nell'analisi di sei casi aziendali (§16.4) in termini di: (i) Fonti di ricavo e peso economico relativo; (ii) governance e logiche di gestione delle entrate non istituzionali; (iii) innovazioni nei modelli di offerta e *pricing*. Infine, vengono discusse le principali evidenze (§16.5) e tracciate le implicazioni manageriali e di policy (§16.6).

16.2 Le teorie di riferimento

16.2.1 L'autonomia gestionale nelle organizzazioni sanitarie pubbliche

Il tema dell'autonomia gestionale nelle aziende sanitarie pubbliche si colloca nel quadro delle riforme di ispirazione New Public Management (NPM), che a partire dagli anni Ottanta hanno introdotto nella pubblica amministrazione logiche manageriali orientate ai risultati, all'efficienza e alla responsabilità economica (Hood, 1991; Pollitt & Bouckaert, 2017).

Nel contesto italiano, questa transizione si è concretizzata con i decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993, che hanno trasformato le unità sanitarie locali in aziende dotate di personalità giuridica, autonomia organizzativa e responsabilità economico-finanziaria. Tale processo, definito "aziendalizzazione del SSN", ha introdotto un modello di governance in cui il management sanitario è chiamato a coniugare efficienza economica, qualità dell'assistenza e accountability pubblica.

La letteratura internazionale ha descritto questa evoluzione come il passaggio da una logica di amministrazione per regole a una logica di amministrazione per risultati (Pollitt & Talbot, 2004), evidenziando come l'autonomia, per essere efficace, debba restare "vincolata" da sistemi di controllo e di misurazione della performance. In sanità, ciò si traduce in una tensione permanente tra libertà gestionale e responsabilità pubblica, che richiede competenze manageriali, trasparenza e capacità di rendicontazione (Ferlie & Shortell, 2001).

A livello comparato, diversi studi dell'OECD (2017, 2022) e dell'*European Observatory on Health Systems and Policies* (Saltman & Duran, 2021) mostrano che la devoluzione di autonomia alle aziende sanitarie può migliorare la qualità delle decisioni locali e la capacità di adattamento ai bisogni territoriali, ma solo se accompagnata da sistemi informativi robusti e incentivi coerenti.

Quando, al contrario, la responsabilità economica non si accompagna a effettivi margini decisionali, si producono forme di accountability rituale e comportamenti difensivi che ostacolano l'innovazione.

16.2.2 Quasi-mercati, pluralità degli erogatori e logiche di co-produzione

La progressiva apertura del sistema sanitario italiano alla collaborazione pubblico–privato ha dato vita a un modello di quasi-mercato sanitario (Le Grand, 1991; Saltman, 2002), in cui le Regioni e le aziende di committenza agiscono come acquirenti e una pluralità di erogatori – pubblici e privati accreditati – competono per la produzione di servizi in un contesto regolato.

In questo contesto, l'autonomia gestionale si estende anche agli attori privati accreditati, che operano secondo logiche di mercato regolato: i prezzi e i volumi sono definiti dalle amministrazioni pubbliche, ma le strutture mantengono ampi margini di discrezionalità gestionale e strategica (Carbone, 2013; Giudice, Preti & Ricci, 2023).

La letteratura sul quasi-mercato riconosce che questo modello produce ibridazione organizzativa: le aziende pubbliche assumono strumenti di management tipici delle imprese, mentre le strutture accreditate sono soggette a standard pubblici di qualità, appropriatezza e trasparenza (Fattore, 1999; Saltman, 2015).

Ne deriva una forma di autonomia negoziata, in cui la capacità di generare e gestire risorse – anche non istituzionali – dipende dall'interazione tra regole, contratti e margini di flessibilità concessi dalle Regioni.

Gli studi dell'OECD (2022) e dell'*European Observatory* (Saltman & Duran, 2021) sottolineano che la pluralità di fonti di finanziamento – pubbliche, assicurative e private – può rappresentare una leva di sostenibilità del sistema sanitario, a condizione che non comprometta l'equità di accesso alle cure. In quest'ottica, la produzione di ricavi non istituzionali è interpretata come una forma di co-produzione del valore pubblico (Osborne, Radnor & Nasi, 2013): un modo per garantire risorse aggiuntive e innovazione, mantenendo il mandato universalistico del SSN.

16.2.3 Service model innovation e modelli di ricavo in sanità

Negli ultimi anni, la letteratura sul management sanitario ha esteso l'analisi oltre la dimensione istituzionale, esplorando i modelli di servizio e i revenue model delle organizzazioni sanitarie.

Un modello di servizio descrive il modo in cui un'organizzazione crea, distribuisce e cattura valore (Teece, 2010); il revenue model ne rappresenta la componente economica, ossia le modalità con cui i flussi di valore si traducono in ricavi. In ambito sanitario, questi concetti assumono caratteristiche peculia-

ri, data la presenza di molteplici stakeholder e la coesistenza di obiettivi economici e sociali (Denis, Ferlie & Van Gestel, 2015).

Le esperienze internazionali documentano una transizione dai modelli basati sul volume (*fee-for-service*) a quelli centrati sul valore (*value-based healthcare*), nei quali la remunerazione dipende dagli esiti di salute e dalla qualità complessiva del percorso assistenziale (Porter & Lee, 2013; OECD, 2022).

Parallelamente, la digitalizzazione dei servizi ha reso possibile l'emergere di nuovi canali di ricavo, come abbonamenti, pacchetti di servizi, telemedicina o piattaforme di monitoraggio remoto, che consentono di creare relazioni continuative con i pazienti e di generare ricavi ricorrenti (Agarwal *et al.*, 2020).

Nel contesto italiano, i Rapporti OASI del CeRGAS Bocconi (2019-2024) hanno analizzato negli anni la capacità da parte delle aziende del SSR di generare ricavi non istituzionali, tuttavia mancano analisi specifiche sul tema. Inoltre, le evidenze disponibili mostrano come queste esperienze restino ancora frammentate e spesso non integrate nella pianificazione strategica aziendale, a causa di vincoli regolatori, rigidità tariffarie e carenze nei sistemi di misurazione del valore prodotto.

Dalla letteratura emergono tre linee interpretative convergenti.

- L'autonomia come prerequisito per l'innovazione. L'efficacia dei sistemi sanitari decentrati dipende dalla capacità delle organizzazioni di esercitare discrezionalità decisionale ed economica in coerenza con la missione pubblica (Ferlie & Shortell, 2001; OECD, 2022).
- La pluralità dei finanziamenti come leva di sostenibilità. L'integrazione di fonti pubbliche e private può rafforzare la resilienza del sistema, se governata da regole trasparenti e da una visione di lungo periodo (Saltman & Duran, 2021).
- La necessità di modelli di ricavo ibridi e orientati al valore. La trasformazione dei modelli di servizio in sanità richiede meccanismi di remunerazione che premino gli esiti di salute e la capacità di innovare i servizi (Porter & Lee, 2013; Teece, 2010).

Nonostante il crescente interesse per questi temi, la letteratura evidenzia un vuoto conoscitivo sulla relazione tra autonomia gestionale e ricavi non istituzionali.

La maggior parte degli studi si concentra sui meccanismi di finanziamento pubblico e sulla governance istituzionale, trascurando l'analisi delle strategie economiche e manageriali attraverso cui le aziende sanitarie generano valore aggiuntivo e autonomia finanziaria.

Questo capitolo intende colmare tale lacuna, proponendo un quadro teorico integrato che metta in relazione livello di autonomia, natura dei ricavi e innovazione del modello di servizio, con particolare riferimento al sistema sanitario italiano.

16.3. Il metodo di ricerca

16.3.1 Gli obiettivi di ricerca e il framework di analisi

L'obiettivo generale della ricerca è comprendere come e in quale misura i ricavi non istituzionali contribuiscano ad ampliare lo spazio di autonomia gestionale delle aziende sanitarie italiane, pubbliche e private accreditate.

In particolare, la ricerca si propone di:

- mappare le configurazioni dei ricavi non istituzionali nelle diverse tipologie di aziende sanitarie (ospedaliere, territoriali, IRCCS, gruppi accreditati);
- analizzare i meccanismi organizzativi, economici e istituzionali che ne abilitano o limitano lo sviluppo;
- valutare la relazione tra livello di autonomia gestionale, natura dei ricavi e grado di innovazione del modello di servizio, identificando *pattern* ricorrenti e differenze sistemiche tra pubblico e privato accreditato.

Il framework di analisi è costruito sulla base del quadro teorico elaborato nel paragrafo precedente, che interpreta l'autonomia gestionale come una variabile multidimensionale derivante dall'interazione tra fattori economici, regolatori e organizzativi.

In particolare, la ricerca si concentra su tre dimensioni analitiche principali.

a. Livello di autonomia gestionale, inteso come grado di discrezionalità decisionale e finanziaria che le aziende possono esercitare nell'allocazione delle risorse e nella definizione dei propri modelli di servizio (Pollitt & Bouckaert, 2017; Saltman & Duran, 2021).
b. Natura dei ricavi non istituzionali, ovvero la composizione delle fonti di reddito autonome – attività libero-professionali, prestazioni a pagamento diretto, convenzioni con imprese o fondi, attività di ricerca e formazione, partnership digitali – e il loro peso relativo sul bilancio complessivo.
c. Grado di innovazione del modello di ricavo, inteso come capacità di introdurre nuove forme di relazione economica con utenti e stakeholder (es. abbonamenti, servizi digitali, percorsi personalizzati, modelli value-based).

Combinando queste tre dimensioni, il framework consente di identificare diverse configurazioni di autonomia:

- autonomia vincolata, tipica delle aziende pubbliche con scarsa flessibilità economica;
- autonomia negoziata, che caratterizza le strutture pubbliche o accreditate capaci di attivare canali integrativi di finanziamento;

- autonomia imprenditoriale, in cui la gestione dei ricavi non istituzionali diviene leva strategica per la sostenibilità e l'innovazione.

L'assunto di partenza è che la capacità di sviluppare e governare ricavi autonomi rappresenti una proxy della maturità manageriale e della propensione all'innovazione organizzativa, con effetti positivi attesi sulla sostenibilità economica e sull'efficacia complessiva del sistema sanitario (Ferlie & Shortell, 2001; OECD, 2022).

16.3.2 Il metodo di analisi

La ricerca adotta una metodologia qualitativa comparativa, fondata su analisi di casi multipli (*multiple case study design*) secondo l'approccio di Yin (2018).

Tale scelta metodologica è motivata dalla natura esplorativa dell'indagine e dalla volontà di comprendere i meccanismi generativi che collegano autonomia gestionale, governance e modelli di ricavo, più che di misurare relazioni causali di tipo quantitativo. Il campione è composto da sei casi di aziende sanitarie, equamente distribuite tra:

- tre pubbliche territoriali in tre regioni diverse e con differenti gradi di contaminazione con l'ambito universitario;
- tre private accreditate (un'azienda a vocazione ambulatoriale profit, una a vocazione ospedaliera profit e una a vocazione ospedaliera non profit).

I casi sono stati selezionati secondo un criterio di rilevanza teorica e varietà di configurazione (*maximum variation sampling*), al fine di rappresentare diversi modelli regionali (Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano), seppur tutti caratterizzati da una certa rilevanza del settore out-of-pocket, e differenti livelli di autonomia finanziaria.

L'analisi si basa su una triangolazione di tre fonti principali.

- Interviste semi-strutturate a figure apicali (Direttori Generali, CFO, Responsabili controllo di gestione, Direttori amministrativi e Direttori sviluppo strategico).
- Analisi documentale di bilanci d'esercizio, piani strategici, relazioni di gestione e contratti regionali.
- Osservazione indiretta e *desk analysis* di fonti pubbliche, report istituzionali, siti web aziendali e articoli di stampa economica specializzata.

Tutte le informazioni sono state trattate in forma aggregata e anonima, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati e con i principi etici della ricerca.

I dati raccolti sono stati analizzati attraverso un processo di codifica tematica iterativa (Miles, Huberman & Saldaña, 2014), articolato in tre fasi:

- Codifica aperta, per identificare concetti ricorrenti legati ai ricavi, all'autonomia e ai vincoli istituzionali;
- Raggruppamento teorico, per organizzare i codici secondo le tre dimensioni del framework (autonomia, natura dei ricavi, innovazione del modello);
- Analisi comparativa, per individuare pattern ricorrenti e differenze tra cluster pubblico e privato accreditato.

I risultati sono stati sistematizzati in una matrice caso-dimensione che permette di confrontare i livelli di autonomia gestionale e le configurazioni dei ricavi non istituzionali.

Tale approccio, coerente con la tradizione CeRGAS di ricerca empirica applicata, consente una generalizzazione analitica e non statistica, finalizzata a elaborare modelli interpretativi trasferibili ad altri contesti del SSN (Eisenhardt, 1989; Yin, 2018).

Per garantire la solidità dei risultati, la ricerca ha adottato diversi accorgimenti metodologici:

- triangolazione delle fonti (interviste, documenti, dati quantitativi);
- verifica incrociata delle informazioni con esperti di OCPS (Osservatorio Consumi Privati in Sanità) e referenti aziendali;
- audit trail documentale, per garantire trasparenza e tracciabilità del processo analitico.

Questo disegno metodologico consente di rispondere in modo sistematico alle domande di ricerca, esplorando in che modo i ricavi non istituzionali si configurano come leva di autonomia e innovazione nelle diverse tipologie di aziende sanitarie italiane.

16.4 I risultati

L'analisi empirica ha riguardato sei aziende sanitarie – tre pubbliche (ASST Brescia, AUSL Piacenza, Azienda Sanitaria dell'Alto Adige) e tre private o private non profit (Centro Diagnostico Italiano, Fondazione Don Gnocchi, Policlinico San Donato) – scelte per rappresentare differenti combinazioni di assetto proprietario, missione e livello di maturità gestionale.

L'interpretazione dei casi segue il framework metodologico illustrato nel paragrafo precedente, articolato in tre dimensioni analitiche – autonomia gestionale, natura dei ricavi e innovazione del modello di servizio – tradotte, ai fini empirici, nelle tre aree di osservazione riportate di seguito:

- fonti di ricavo e peso economico relativo, come proxy della natura e composizione dei ricavi non istituzionali;
- governance e logiche di gestione, quale espressione del livello di autonomia gestionale;
- innovazioni nei modelli di offerta e pricing, come indicatori del grado di innovazione del modello di ricavo.

16.4.1 Fonti di ricavo e peso economico

Le fonti di finanziamento extra-SSR restano marginali nelle aziende pubbliche, dove oscillano tra l'1,5% e il 4% dei ricavi complessivi.

- ASST Brescia registra 56 milioni di entrate proprie su un bilancio di 949 milioni (≈6%), ma depurando ticket e voci istituzionali, la quota effettiva riconducibile ad attività "a mercato" si riduce al 3–4%.
- AUSL Piacenza si colloca su valori inferiori (1,5%), con la libera professione che registrava un valore di circa 7 milioni nel 2024, a fronte di 735 milioni di ricavi totali.
- Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, per specificità normativa e struttura del finanziamento provinciale, dichiara fonti non istituzionali inferiori al 2%, con donazioni ed eredità come fonti residuali (50–100 mila €/anno).

Nel privato, le percentuali cambiano radicalmente:

- Centro Diagnostico Italiano (CDI) presenta una composizione dei ricavi con 50% da fondi e assicurazioni, 23% da SSN e 13% da pagamenti diretti out-of-pocket.
- Fondazione Don Gnocchi dichiara un'attività privata pari al 10% dei ricavi totali (circa 30 milioni su 300), mentre le donazioni oscillano tra 15 e 20 milioni annui.
- Policlinico San Donato mantiene un mix più tradizionale (80% SSN, 20% attività solvente), ma con una crescita programmata grazie all'apertura di una nuova ala di degenza dedicata alla solvenza.

Per un quadro di sintesi si veda la Tabella 16.1.

Con riferimento specifico alla solvenza e passando dal peso economico dei ricavi non istituzionali ai modelli di *pricing*, nelle aziende intervistate, in termini economici, il punto di partenza è quasi ovunque la stima dei costi diretti e indiretti – costo del personale sanitario, materiali, utilizzo delle tecnologie, infrastrutture e quota di overhead – che consente di fissare la soglia minima di sostenibilità economica. Tuttavia, le aziende dichiarano che la costruzione del prezzo non si limita a una somma dei costi unitari: nella quasi totalità dei casi,

Tabella 16.1 **La composizione dei ricavi non istituzionali**

Azienda	Assetto	% Ricavi non istituzionali	Voci principali
ASST Brescia	Pubblica	3–4%	Libera prof. (26 mln), sperimentazioni (4–5 mln)
AUSL Piacenza	Pubblica	1,5%	Libera prof., consulenze, donazioni (0,7 mln)
Azienda Sanitaria AA	Pubblica	<2%	Libera prof., locazioni, minime donazioni
CDI	Privato accreditato	77% (fondi + solvente)	Fondi 50%, out-of-pocket 13%, corporate 14%
Don Gnocchi	Privato non profit	10%	Ricoveri e ambulatori solventi, donazioni 15–20 mln
Policlinico San Donato	Privato accreditato	20%	Solvenza, pacchetti prevenzione, cooperazione internazionale

Fonte: elaborazione degli autori

il prezzo finale è frutto di una mediazione tra costo interno, tariffe di riferimento del SSN e benchmark di mercato, posizionandosi spesso in una fascia intermedia.

Il ruolo dei costi nei modelli di *pricing* è quindi rilevante ma non determinante: servono come bussola per evitare squilibri strutturali, mentre la decisione finale incorpora obiettivi di attrattività, equità e differenziazione. Nelle strutture private (come CDI, Policlinico San Donato e Fondazione Don Gnocchi), la leva di prezzo viene usata strategicamente per sostenere la crescita di segmenti specifici – ad esempio la prevenzione o la riabilitazione – applicando scontistiche o tariffe flat per pacchetti, e mantenendo una coerenza rispetto al posizionamento reputazionale (§1.4.3). Nel pubblico (AUSL Piacenza, Alto Adige) i margini di manovra sono più ristretti, ma il riferimento ai costi interni è comunque cruciale per negoziare con la Regione o giustificare revisioni tariffarie.

16.4.2 Governance e logiche di gestione

Le evidenze comparative mostrano una netta distinzione tra il pubblico e il privato nella governance delle entrate non istituzionali. Nelle aziende pubbliche si osserva una prevalente logica amministrativa: le responsabilità sono distribuite tra ragioneria, controllo di gestione e uffici intramoenia, con scarsa integrazione in una logica strategica complessiva. L'AUSL di Piacenza sintetizza così: «Non abbiamo una funzione pricing né un ufficio dedicato alle attività solventi: queste entrate sono considerate un "plus", non un driver».

Eccezione degna di nota è ASST Brescia, che ha realizzato una innovazione di governance: è stata istituita una commissione interna che alimenta un fondo direzionale attraverso una quota (circa 30%) dei proventi derivanti dalle sperimentazioni cliniche (4-5 milioni/anno), e tale fondo è destinato a investimenti in tecnologie e infrastrutture. Come riporta un membro della direzione strategica: «Abbiamo creato un fondo per finanziare investimenti che la Regione

non copre. È il modo più concreto per tradurre la ricerca in capacità di innovazione organizzativa». Le altre aziende pubbliche, come l'Alto Adige, dichiarano una scelta politica esplicita di non puntare sull'autofinanziamento: «Non intendiamo garantire il diritto alla salute con fondi privati. La Provincia copre integralmente il fabbisogno».

Nel contesto privato, la governance risulta fortemente orientata ai fabbisogni emergenti e al controllo strategico. Il Centro Diagnostico Italiano ha istituito una funzione di pricing management all'interno della direzione operativa che differenzia listini per segmenti di domanda e territorio («Abbiamo listini specifici per Milano, Varese e Pavia, e monitoriamo costantemente la redditività per segmento»). La Fondazione Don Gnocchi ha centralizzato la definizione delle tariffe, introdotto un «Regolamento Solvenza» uniforme per tutte le sedi e fa dipendere le politiche di prezzo dal controllo di gestione: «Abbiamo voluto mantenere tariffe calmierate: la nostra offerta privata serve a finanziare i servizi che un'azienda profit eliminerebbe il giorno uno». Il Policlinico San Donato, infine, adotta un modello di governance industriale con analisi dei volumi, cluster di domanda e marginalità dei percorsi: «La prevenzione è il nostro nuovo motore di crescita. Passare dalla prestazione al percorso è il modo per rendere sostenibile la salute».

In sintesi, la differenza non è solo quantitativa (peso delle entrate), ma soprattutto qualitativa: la presenza di strutture dedicate, la definizione di policy interne e la capacità di reinvestire risorse sono elementi distintivi della maturità gestionale.

Anche il ruolo degli intermediari (fondi sanitari, assicurazioni, enti di welfare aziendale) costituisce una significativa linea di differenziazione tra i sei casi analizzati, soprattutto per impatto sulla governance clinico-manageriale.

Nelle realtà pubbliche (ASST Brescia, AUSL Piacenza, Azienda Sanitaria dell'Alto Adige) il ruolo degli intermediari è marginale e quasi mai strutturato.

- A Brescia, le convenzioni con fondi o assicurazioni sono definite "episodiche" e gestite prevalentemente su base B2B tra strutture pubbliche o con imprese locali ("stipuliamo convenzioni con ditte private per screening o analisi di laboratorio, ma su numeri molto contenuti"). I professionisti non sono direttamente coinvolti nel rapporto con i fondi: la relazione è amministrativa e non influenza le scelte cliniche o tariffarie.
- All'AUSL di Piacenza, gli interlocutori assicurativi sono quasi assenti. Come conferma la direzione: *«Non siamo un'azienda universitaria né ospedaliera, e non abbiamo accordi con fondi integrativi; l'attività a mercato è limitata alla libera professione».*
- L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ammette di non avere partnership assicurative, né di volerle sviluppare. La Provincia mantiene il monopolio del finanziamento della sanità e scoraggia l'uso di intermediari privati.

In tutti e tre i casi, quindi, i fondi sono assenti come canale di ricavo e come soggetto di governance: la relazione economica rimane esclusivamente bilaterale tra cittadino e azienda.

Nei privati accreditati, al contrario, i fondi sanitari si caratterizzano come i "pagatori dominanti": gli intermediari rappresentano un pilastro del modello di servizio e incidono profondamente sulle logiche di pricing, di organizzazione dell'attività clinica e di rapporto con i medici.

- Nel Centro Diagnostico Italiano (CDI), i fondi e le assicurazioni generano circa il 50 % dei ricavi, a fronte di un 23% da SSN e un 13% da solventi. Il rapporto con i fondi è descritto come "monolitico": le tariffe sono fissate a livello nazionale e poco negoziabili. Come afferma il direttore operativo: *«I fondi hanno listini nazionali. È molto difficile far capire che i nostri costi aumentano. Alcuni hanno addirittura erogatori interni e ci posizionano in basso nei loro portali».* Questa rigidità, che vale sia sulle prestazioni a rimborso diretto, che quelle a rimborso indiretto, limita i margini sul prezzo, ma garantisce stabilità di volumi. I medici non negoziano direttamente con i fondi: il pricing è centralizzato, ma i volumi convenzionati incidono sulla loro remunerazione.
- Alla Fondazione Don Gnocchi, il rapporto con gli intermediari è più selettivo. Solo il 10% delle attività private passa attraverso fondi o assicurazioni, con incidenza maggiore nella diagnostica rispetto alla riabilitazione, che «*non è contemplata nei nomenclatori dei principali fondi*». Qui gli intermediari sono percepiti come "strumento di accessibilità" più che come leva di profitto: la Fondazione accetta convenzioni a tariffe più basse per garantire accesso, ma mantiene il controllo sul posizionamento etico dei prezzi (*«Lavorare con i fondi ci serve a raggiungere pazienti che altrimenti resterebbero esclusi, ma non deve diventare un vincolo economico che snatura la nostra missione»).*
- Nel Policlinico San Donato, gli intermediari sono parte integrante del modello commerciale. I fondi coprono una quota significativa della solvenza e influenzano direttamente le politiche tariffarie. Il direttore operativo sottolinea: *«Il nostro segmento più importante è quello dei fondi: rappresentano quasi la metà del fatturato. Ma la loro rigidità ci spinge a lavorare sui pacchetti di prevenzione, dove possiamo fissare il prezzo e offrire valore aggiunto».* Qui gli intermediari sono veri *"price makers"*: definiscono le condizioni di rimborso, costringendo l'azienda a differenziare l'offerta per non comprimere i margini. I medici, remunerati a percentuale, risentono direttamente di tali vincoli tariffari, che ne influenzano la produttività e la propensione a operare con clienti solventi.

Queste evidenze suggeriscono una triplice tipologia di rapporto con gli intermediari.

1. Assente (pubblico) – il cittadino resta pagatore diretto e la relazione economica è lineare; i medici operano in autonomia, senza influenza di fondi o assicurazioni nella definizione del *pricing*.
2. Vincolante (privato accreditato industriale) – il fondo è pagatore dominante, stabilisce listini e standard di servizio; il medico diventa "ingranaggio" di un sistema a volumi garantiti e margini compressi (es. CDI, San Donato).
3. Selettivo (privato non profit) – il fondo è accettato come facilitatore di accesso, ma i volumi intermediati restano ridotti e la governance dei prezzi e la missione restano in capo all'ente (es. Don Gnocchi).

Nel complesso, gli intermediari rappresentano un nuovo baricentro di potere economico nel sistema sanitario misto italiano. Nel pubblico restano marginali, ma nel privato condizionano in misura crescente sia la strategia aziendale sia la micro-economia della prestazione medica.

Le differenze più rilevanti riguardano:

- la disintermediazione (pubblico) versus la multicanalità regolata (privato);
- il diverso grado di autonomia dei clinici, liberi di fissare i propri onorari nel pubblico, ma vincolati dai listini nel privato accreditato;
- e infine la funzione sociale dei fondi, che nelle realtà non profit diventano leve di inclusione, mentre in quelle industriali sono strumenti di standardizzazione e competizione tariffaria.

Come ha osservato il manager di una struttura privata: *«L'assicurazione non compra più solo la prestazione, ma il processo. Chi non controlla il processo – medico compreso – è destinato a perdere potere»*.

16.4.3 Innovazioni nel modello di offerta e pricing

Quanto alle innovazioni, emergono tre traiettorie distinte. Nelle aziende pubbliche, l'innovazione si muove prevalentemente sul versante finanziario-organizzativo, piuttosto che sull'offerta clinica o sul pricing vero e proprio. Ad esempio, ASST Brescia ha introdotto modalità di redistribuzione delle risorse da ricerca verso investimenti strategici, mentre nel resto del settore pubblico il pricing rimane regolato e le esperienze di convenzioni B2B o libere professioni sono ancora limitate.

Nel settore privato, invece, l'innovazione riguarda in primo luogo la costruzione di percorsi di valore e la differenziazione dell'offerta. Il Centro Diagnostico Italiano segmenta chiaramente la domanda in quattro canali (SSN, fondi, out-of-pocket, corporate) e ha sviluppato strumenti di fidelizzazione come la "Fidati Card" e convenzioni aziendali, con 50.000 check-up all'anno. La Fondazione Don Gnocchi applica tariffe giornaliere «omnicomprensive» nei rico-

veri riabilitativi (tre fasce clinico-assistenziali) e mantiene politiche di prezzo inferiori ai competitor per coerenza con la propria missione sociale. Il Policlinico San Donato ha introdotto pacchetti personalizzati di prevenzione – per fasce d'età, genere o rischio clinico – e leve di sconto per volumi in logica B2B. Tale orientamento implica un passaggio dal modello "*fee-for-service*" alla logica "percorso/pacchetto", e rappresenta un indicatore della frontiera di innovazione nel settore sanitario.

L'analisi incrociata dei casi mostra, inoltre, che il ruolo dei medici nella generazione e gestione dei ricavi non istituzionali è tanto cruciale quanto eterogeneo nei diversi contesti organizzativi.

Nelle aziende pubbliche, la libera professione resta la principale fonte di reddito "a mercato". Ad esempio, all'AUSL di Piacenza il 53% dei medici esercita l'attività libero-professionale, ma con forte concentrazione del fatturato («*l'80 % dei ricavi della libera è prodotto dal 20% dei medici*»). La Direzione aziendale segnala inoltre di aver introdotto, e progressivamente ampliato, forme di "libera professione calmierata" rivolte ai giovani specialisti, con l'obiettivo di favorirne l'accesso all'attività libero-professionale attraverso tariffe più basse e percorsi regolati, «*una via di mezzo tra la libera tradizionale e l'attività istituzionale*».

All'ASST Spedali Civili di Brescia, la libera professione è gestita da circa un migliaio di medici e deve risultare "in pareggio" per normativa regionale; le tariffe sono determinate dai professionisti stessi: «s*ono i medici che decidono i loro onorari*». Tuttavia, non esiste una regia centrale forte: «*non esiste una strategia di sfruttamento del canale libero professionale, è una scelta del singolo*».

Nel caso dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, la direzione ha introdotto un taglio orario alla libera professione per spingere l'attività istituzionale: «*una riduzione di un'ora a settimana per dare un segnale che serve più lavoro sul pubblico*». Anche qui i medici fissano autonomamente i propri onorari, ma la Provincia limita le ore di attività a sei ore a settimana.

Nel privato accreditato e non profit, invece, la figura del medico assume un ruolo più strettamente integrato nei meccanismi economici.

Alla Fondazione Don Gnocchi, i professionisti rappresentano «*il 70-80 % del costo complessivo della prestazione*» e ricevono compensi proporzionali al fatturato generato («*per l'attività ambulatoriale riconosciamo una percentuale su quanto fatturato al paziente*»). Nella degenza, invece, gli incentivi sono collettivi e legati ai risultati del primario, non al singolo medico, per evitare distorsioni competitive.

Nel gruppo San Donato, i medici – quasi tutti liberi professionisti – sono parte integrante del modello di funzionamento e compartecipano alla generazione di ricavi. Il loro costo è la principale variabile nella definizione del prezzo ("*la componente del costo del medico è fondamentale*"), ma anche la leva per l'efficienza: «*quanto più il percorso integra diversi specialisti, tanto più si riduce il prezzo medio al paziente*».

Nel Centro Diagnostico Italiano, infine, i clinici partecipano indirettamente alla costruzione tariffaria attraverso il dialogo costante con la funzione pricing: la remunerazione è proporzionata alle tariffe di mercato e all'equilibrio con i fondi assicurativi.

Nel complesso, i materiali documentali mostrano che:

- nel pubblico prevale una gestione decentrata e autonoma della libera professione, con limitata integrazione nella strategia aziendale e, talvolta, tensioni tra tempo istituzionale e privato;
- nel privato e nel non profit, il medico è parte di un sistema economico coordinato, dove la sua remunerazione è variabile in funzione della produttività e del posizionamento di mercato, ma anche incanalata in politiche di team e di equità.

Come sintetizzato da un direttore sanitario intervistato: «*Il medico oggi non è solo un erogatore di prestazioni, ma un attore del modello di gestione dell'azienda: quanto genera, come lo genera e per chi lo genera diventano parte della governance aziendale*.»

Nel complesso, questi casi mostrano come la capacità di innovare il modello di offerta, governare le entrate non istituzionali e integrare tali leve nella strategia aziendale costituisca un forte elemento di differenziazione nella sanità contemporanea.

16.5 Discussione

L'analisi dei sei casi conferma che la gestione delle fonti di ricavo non istituzionali rappresenta oggi una delle frontiere più rilevanti – e più disomogenee – della managerialità in sanità.

La ricerca mostra come, anche in assenza di vincoli formali stringenti, le organizzazioni differiscano profondamente nella capacità di leggere le opportunità emergenti nel settore, istituzionalizzarle in strumenti di governance e riutilizzarne i frutti a fini strategici.

La lettura trasversale dei casi ha permesso di costruire una matrice di maturità dei modelli di revenue, coerente con il framework teorico illustrato nei paragrafi precedenti (Pollitt & Bouckaert, 2017; Teece, 2010). Gli assi interpretativi della matrice riprendono infatti le due dimensioni chiave emerse dal quadro concettuale:

- la governance economico-finanziaria riflette il grado di autonomia e capacità di gestione delle risorse (Ferlie & Shortell, 2001; Saltman & Duran, 2021), che può essere di natura più amministrativa o strategica;

- l'innovazione del modello di offerta e pricing, espressione della capacità di ripensare la creazione di valore (Porter & Lee, 2013; Teece, 2010), che può essere di natura più tradizionale o *market-driven*.

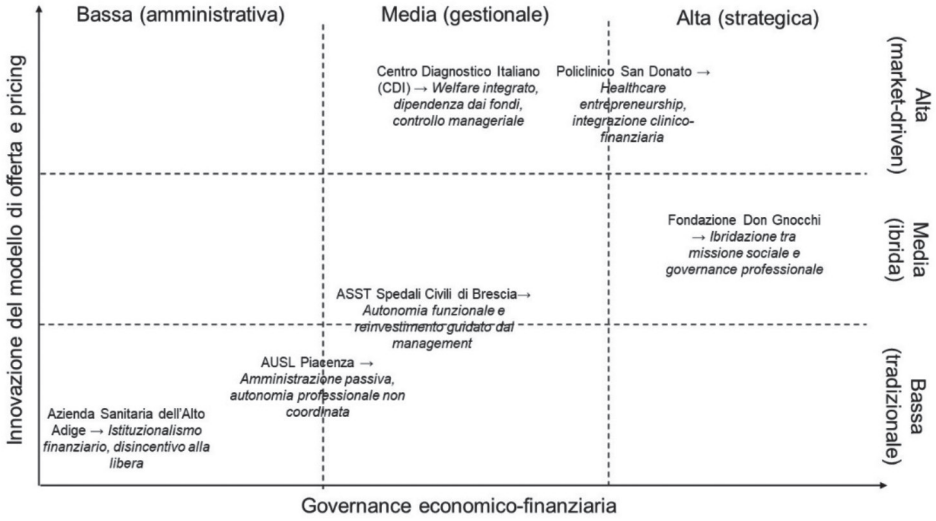
I risultati, sintetizzati in Figura 16.1 mostrano come la combinazione di asset-to proprietario, storia istituzionale e cultura organizzativa produce differenze marcate nella maturità del modello di revenue, che può essere letta attraverso tre stadi evolutivi:

1. Amministrazione passiva delle entrate "extra", dove le risorse non istituzionali sono registrate ma non governate;
2. Gestione attiva e reinvestimento strategico, in cui l'autonomia economica è esercitata con finalità di sostenibilità e innovazione;
3. Integrazione industriale e *market-driven*, dove il modello di servizio incorpora logiche di mercato, segmentazione della domanda e strumenti di pricing evoluto.

La matrice visualizza un chiaro gradiente di maturità tra pubblico e privato:

- Le aziende pubbliche (quadrante sinistro) restano ancorate a logiche di controllo amministrativo, sebbene casi come Brescia mostrino segnali di passaggio verso una gestione proattiva delle risorse.

Figura 16.1 **Matrice di maturità dei modelli di revenue nelle aziende sanitarie pubbliche e private**



Fonte: elaborazione degli autori

- Le organizzazioni private e non profit (quadranti inferiori e di destra) incorporano invece il *revenue model* nella strategia aziendale, utilizzando il pricing e la segmentazione come leve di posizionamento e fidelizzazione.

Un dirigente di Brescia sintetizza efficacemente la tensione di questo passaggio: «*Non basta saper contabilizzare i ricavi: bisogna saperli far parlare, trasformarli in investimenti, in margini di libertà gestionale*».

Nel privato, la stessa consapevolezza si traduce in una logica imprenditoriale compiuta. Al CDI, la funzione pricing lavora su analisi di elasticità territoriale: «*A Milano i prezzi sono un indicatore di qualità percepita; a Varese devono invece restare accessibili: il margine non è nel prezzo ma nel volume*». La Fondazione Don Gnocchi lega invece la costruzione tariffaria alla propria identità etica: «*Le nostre tariffe calmierate garantiscono accesso e permettono di finanziare le linee di attività meno sostenibili economicamente*». San Donato, infine, traduce la strategia di gruppo in una *prevention economy* basata su percorsi personalizzati e pacchetti di check-up: «*Il paziente non compra una prestazione ma un'esperienza di salute, costruita su misura*».

Il coinvolgimento dei medici rappresenta, poi una variabile cruciale di differenziazione. Nel settore pubblico, la libera professione resta perlopiù una scelta individuale, poco coordinata con le strategie aziendali. A Brescia e Piacenza i professionisti fissano autonomamente i propri onorari: *«Il prezzo della visita lo decide il medico, non l'azienda»* (dirigente ASST Brescia). Tuttavia, mancano meccanismi di allineamento: *«Non c'è una regia centrale, è un mondo a parte»* (AUSL Piacenza). Nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, al contrario, il governo provinciale limita la libertà professionale: *«Abbiamo ridotto le ore di libera professione per spingere l'attività istituzionale»*, segnala la direzione sanitaria.

Nel privato accreditato, i medici diventano parte integrante dei revenue model. Al CDI e al Policlinico San Donato, la remunerazione è collegata direttamente ai volumi di prestazioni e ai contratti con fondi assicurativi. Ciò sposta l'asse di potere dal singolo clinico al sistema: i medici non fissano i prezzi, ma li applicano all'interno di modelli di standardizzati e monitorati da funzioni pricing. Nelle organizzazioni non profit, come Don Gnocchi, il rapporto è più bilanciato: la componente medica è riconosciuta come fattore produttivo chiave ("il 70-80% del costo complessivo della prestazione"), ma la governance rimane centrata su criteri etici e di accessibilità.

Quindi, i medici svolgono un ruolo centrale, sia tecnico sia "politico", nel processo di pricing: contribuiscono alla definizione dei contenuti clinici dei pacchetti e alla valutazione della loro fattibilità, e in molti casi – come in San Donato, Don Gnocchi e CDI – partecipano attivamente ai tavoli di costruzione dell'offerta. La loro competenza clinica è essenziale per bilanciare appropriatezza e sostenibilità, ma rappresentano anche un elemento di differenziazione

di mercato, poiché il valore percepito dal paziente (e dunque la disponibilità a pagare) è spesso legato al nome del professionista. In sintesi, i costi forniscono la struttura economica, i medici danno contenuto e legittimità clinica, mentre il management esercita la sintesi strategica tra sostenibilità, attrattività e coerenza regolatoria.

In questo quadro, nel pubblico prevale una logica bottom-up e frammentata; nel privato, una logica top-down e integrata; nel non profit, una logica concertata e valoriale.

Un'altra grande differenza riguarda la presenza e l'influenza degli intermediari finanziari (fondi, assicurazioni, welfare aziendale).

Nel settore pubblico, il rapporto è pressoché assente: le aziende lavorano quasi esclusivamente con pazienti diretti. Nel privato, invece, i fondi rappresentano una leva di scala e stabilità, ma anche una fonte di vincolo competitivo. Il CDI trae metà del suo fatturato dai fondi, ma subisce la rigidità dei loro listini: *«I fondi sono monolitici, i prezzi sono nazionali. Non puoi discutere i margini, puoi solo lavorare sui volumi»*. Il Policlinico San Donato riconosce nei fondi «i*l principale driver del mercato*», ma compensa, come pure fa il CDI, questa dipendenza sviluppando percorsi di prevenzione venduti direttamente a imprese e privati: una forma di «*diversificazione anti-fondo*». La Fondazione Don Gnocchi, infine, utilizza i fondi in modo selettivo, come leva di accessibilità più che di profitto: *«Le convenzioni servono a includere, non a massimizzare»*.

In sintesi:

- nel pubblico prevale la disintermediazione (assenza di fondi);
- nel privato industriale, la dipendenza regolata (fondi come pagatori dominanti);
- nel non profit, la mediazione inclusiva (fondi come strumento di equità).

Queste evidenze convergono su tre considerazioni di fondo:

1. Il grado di autonomia economica riflette una competenza istituzionale più che finanziaria. Dove esistono regole interne chiare sulla destinazione delle risorse (come il fondo direzionale di Brescia o il regolamento solvenza di Don Gnocchi), le entrate non istituzionali diventano una leva di innovazione, non un rischio di distorsione.
2. Il pricing e la gestione dei medici sono ormai dimensioni della stessa strategia e sempre più una leva di posizionamento strategico. Nel pubblico, la tariffa rimane un dato; nel privato, è uno strumento per modellare la domanda, differenziare servizi e rafforzare il brand sanitario.
3. L'integrazione tra missione e mercato è la nuova frontiera della sostenibilità. Le realtà più mature (Don Gnocchi, CDI, San Donato) dimostrano che

generare valore economico può essere funzionale alla creazione di valore sociale e reputazionale, in linea con i principi dell'*impact management*.

In conclusione, la comparazione mostra che la maturità di un modello di revenue non dipende unicamente dalla natura giuridica, ma dalla capacità cognitiva e organizzativa di leggere e governare il valore.

Le aziende che hanno internalizzato questa competenza – pubbliche o private che siano – trasformano la dimensione economica in una leva di politica sanitaria. Come sintetizza un direttore intervistato:

«Il futuro della sanità non dipende solo da quanto mercato entra nel pubblico, ma da quanto management entra nella professione».

16.6 Implicazioni manageriali e di policy

Le evidenze dei dati economici delle aziende sanitarie e quelle derivanti dall'analisi dei sei casi evidenzia che la gestione strategica dei ricavi non istituzionali non è più una variabile incidentale, ma una componente rilevante della capacità di sostenibilità del sistema sanitario.

Il quadro che emerge – dalla sperimentazione gestionale di ASST Brescia alla logica industriale del Policlinico San Donato – suggerisce un progressivo passaggio da un modello di controllo amministrativo dei ricavi a uno di governo integrato del valore, in cui le leve economiche, organizzative e reputazionali concorrono a definire la missione aziendale. Tale dinamica emerge con forza e rapidità molto differenti a seconda delle realtà indagate.

Le implicazioni per le aziende sanitarie paiono essere le seguenti:

- Istituzionalizzare la governance delle entrate non istituzionali. Le esperienze di ASST Brescia e Fondazione Don Gnocchi mostrano che la creazione di fondi direzionali, regolamenti solvenza e unità di *pricing management* consentono di governare il ciclo del valore in modo trasparente e strategico. Le aziende dovrebbero dunque dotarsi di policy interne di destinazione e reinvestimento dei proventi non SSN, con reporting periodico alla direzione e al collegio sindacale.
- Integrare le competenze economiche e cliniche. La gestione del pricing e dei percorsi non istituzionali richiede dialogo tra controllo di gestione, direzione sanitaria e professionisti. Nei casi più maturi (CDI, San Donato) la definizione dei pacchetti avviene tramite co-design tra clinici e manager, superando la dicotomia amministrazione/sanità. Per generare valore, occorre favorire la costruzione di team interfunzionali (controllo di gestione, marketing sanitario, direzione medica) per l'analisi dei margini e la progettazione dei servizi.

- Orientare il pricing alla sostenibilità e all'equità. Il pricing non è solo una leva di ricavo ma di posizionamento. Le politiche di Fondazione Don Gnocchi e CDI mostrano che tariffe differenziate e sconti per volumi aziendali possono garantire equilibrio economico senza sacrificare l'accessibilità. Il suggerimento è dunque quello di adottare criteri di *value-based* pricing, bilanciando sostenibilità economica e impatto sociale.

Le implicazioni per i policy maker regionali e nazionali non possono prescindere da:

- Riconoscere e monitorare le fonti di autofinanziamento. Oggi tali flussi non sono tracciati in modo sistematico nei flussi informativi regionali. Una maggiore visibilità consentirebbe di distinguere attività istituzionali da attività non istituzionali e di valutare i modelli di reinvestimento.
- Promuovere la sperimentazione di modelli di partnership pubblico-privato o privato-privato. I casi di Brescia e San Donato mostrano che l'interazione con il capitale privato può generare innovazione, a condizione che siano chiare le regole di trasparenza e destinazione. La raccomandazione è di favorire accordi quadro regionali per progetti di co-finanziamento in ricerca, prevenzione e digitalizzazione, con garanzie di accountability.
- Rivedere il quadro regolatorio della libera professione e della sperimentazione clinica. L'esperienza lombarda suggerisce che la redistribuzione dei proventi può creare incentivi virtuosi senza compromettere l'equità. Va dunque promossa una armonizzazione nazionale delle percentuali di ripartizione e delle modalità di rendicontazione delle attività in solvenza.

La varietà dei modelli osservati invita a un salto di qualità anche nella ricerca di management sanitario.

Sarebbe utile costruire un benchmark nazionale dei modelli di revenue che misuri, oltre ai volumi economici, il livello di governance, l'impatto sulla performance organizzativa e il valore generato per la collettività.

Allo stesso modo, la comparazione tra casi pubblici e privati suggerisce di superare la distinzione dicotomica e analizzare la maturità economico-istituzionale delle aziende sanitarie come una variabile continua.

Il messaggio che emerge dai casi è duplice.

- Sul piano organizzativo, la capacità di gestire le entrate non istituzionali diventa un indicatore della maturità manageriale delle aziende sanitarie.
- Sul piano di sistema, tale capacità è una condizione necessaria per garantire la sostenibilità del servizio sanitario pubblico in un contesto di crescente ibridazione tra missione pubblica e logiche di mercato.

Come ha osservato un interlocutore pubblico durante le interviste: «L'*autonomia finanziaria non significa fare impresa, ma imparare a governare il valore che produciamo*».

16.7 Bibliografia

Agarwal, R., Gao, G., DesRoches, C., & Jha, A. K. (2020). The digital transformation of healthcare: Current status and the road ahead. *Information Systems Research, 31*(1), 1–14. https://doi.org/10.1287/isre.2019.0339

Carbone, C. (2013). *Le aziende sanitarie private accreditate. Regole e posizionamento strategico.* Milano: Egea.

Denis, J.-L., Ferlie, E., & Van Gestel, N. (2015). Understanding hybridity in public organizations. *Public Administration, 93*(2), 273–289. https://doi.org/10.1111/padm.12175

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14(4), 532–550.

Fattore, G. (1999). Cost containment and reform in the Italian National Health Service. *Health Policy, 50*(1–2), 159–172. https://doi.org/10.1016/S0168-8510(99)00006-4

Ferlie, E., & Shortell, S. M. (2001). Improving the quality of health care in the United Kingdom and the United States: A framework for change. *Milbank Quarterly, 79*(2), 281–315. https://doi.org/10.1111/1468-0009.00206

Giudice, L., Preti, L. M., & Ricci, A. (2023). Gli erogatori privati accreditati: inquadramento e posizionamento nell'offerta di specialistica ambulatoriale. In CERGAS (a cura di), *Rapporto OASI 2023. L'aziendalizzazione della sanità italiana: stato dell'arte e prospettive future* (Cap. 4, pp. 145–180). Milano: Egea.

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration, 69*(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Le Grand, J. (1991). Quasi-Markets and Social Policy. The Economic Journal, 101(408), 1256–1267. https://doi.org/10.2307/2234441

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

OECD. (2017). *Tackling Wasteful Spending on Health.* Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264266414-en

OECD. (2022). *Health at a Glance 2022: OECD Indicators.* Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en

Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A new theory for public service management? Toward a (public) service-dominant approach. *Public Management Review, 15*(2), 135–155. https://doi.org/10.1080/14719037.2012.662446

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into the Age of Austerity (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Pollitt, C., & Talbot, C. (2004). Unbundled Government: A Critical Analysis of the Global Trend to Agencies, Quangos and Contractualisation. London: Routledge.

Porter, M. E., & Lee, T. H. (2013). The Strategy That Will Fix Health Care. Harvard Business Review, 91(10), 50–70.

Saltman, R. B. (2002). Regulating Incentives in European Health Care Systems. European Journal of Health Economics, 3(3), 117–126. https://doi.org/10.1007/s10198-002-0108-2

Saltman, R. B., & Duran, A. (2021). Governance, government, and the search for new provider models. Eurohealth, 27(2), 1–6.

Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. *Long Range Planning, 43*(2–3), 172–194. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications